EDUKASI KLINIS ZMC WANARAJA

Lambung Saat Puasa

Keluhan lambung saat puasa biasanya lebih tenang kalau buka pelan, porsi sedang, dan tubuh tidak langsung tiduran.

Buka ringan

Kasih jeda

Waspada red flag

Ringkasan satu kalimat: puasa tetap bisa lebih nyaman bila pola buka, makan malam, sahur, dan jeda menuju tidur dirapikan, tetapi gejala berat tidak boleh dipaksa dianggap keluhan lambung biasa.

1) Pahami dulu: "maag", asam lambung, dan rasa panas di dada tidak selalu sama

Pasien sering menyebut semua nyeri ulu hati sebagai maag. Padahal saat puasa keluhan bisa berupa dispepsia atau lambung terasa begah, bisa juga refluks yaitu rasa asam atau panas yang naik ke dada dan tenggorokan. Penyebutannya beda, tetapi langkah awal amannya mirip: makan lebih tertata, kurangi pemicu, dan kenali tanda bahaya.

Keluhan lambung / dispepsia

Biasanya berupa nyeri ulu hati, perut atas terasa penuh, cepat kenyang, mual, atau begah setelah buka. Saat puasa, pola ini sering muncul kalau buka terlalu berat atau sahur terlalu mepet.

Kapan evaluasi: periksa bila keluhan berulang hampir tiap hari, mengganggu makan, atau tidak membaik setelah pola makan dirapikan.

Refluks / asam lambung naik

Keluhan khasnya rasa panas dari ulu hati ke dada, mulut terasa asam atau pahit, sendawa asam, batuk malam, atau suara serak. Keluhan sering terasa lebih jelas saat habis makan banyak lalu berbaring.

Kapan evaluasi: periksa bila sering kambuh malam, butuh obat terus untuk nyaman, atau terasa sampai mengganggu tidur.

Bukan semua nyeri dada itu lambung

Nyeri yang terasa menekan, menjalar ke rahang, lengan, atau punggung, apalagi disertai sesak, keringat dingin, atau hampir pingsan, tidak aman disebut maag dulu.

Kapan darurat: anggap gawat bila ada nyeri dada berat, muntah darah, BAB hitam, sulit menelan, atau lemas berat.

Konteks praktis: tujuan halaman ini adalah membantu pasien dewasa memilah mana keluhan yang masih bisa dibantu dengan perbaikan pola buka dan sahur, dan mana yang perlu dinaikkan cepat ke dokter atau IGD.

2) Alur aman: buka -> makan utama -> tetap tegak sebelum tidur

Bagian ini mengambil inti terbaik dari versi lama, tetapi dibersihkan supaya lebih mudah dipakai pasien. Fokusnya ada tiga: lambung jangan langsung dihajar porsi besar, beri jeda sebelum makan utama, lalu jangan rebahan setelah makan.

1

Buka ringan dulu

Mulai dengan air putih suhu ruang atau hangat. Bila cocok, boleh tambah 1-2 kurma atau buah yang ringan. Hindari langsung "balas dendam" makan berat.

2

Jeda sebelum makan utama

Kasih jeda sekitar 15-30 menit sebelum nasi dan lauk utama. Tujuannya supaya lambung tidak langsung penuh setelah kosong seharian.

3

Jangan langsung rebahan

Setelah makan malam, tetap duduk tegak atau jalan santai ringan. Jika sering kambuh malam, usahakan ada jeda sekitar 3 jam sebelum tiduran.

Kapan langkah ini tidak cukup: bila keluhan terasa tidak seperti pola biasanya, muntah berulang, sampai tidak bisa masuk minum, atau nyeri dada terasa berat.

3) Saat berbuka: yang membantu lambung, yang sering bikin langsung tidak nyaman

Kemenkes menganjurkan berbuka diawali dengan yang ringan dan mudah dicerna, lalu makan utama setelah jeda. Pada pasien dengan lambung sensitif, saran ini justru makin penting karena beban terbesar biasanya datang dari buka yang terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu berminyak.

Lebih aman saat menit awal berbuka

- Air putih, lalu makanan ringan seperti 1-2 kurma bila cocok, pisang, pepaya, atau sup bening kecil.
- Makan pelan dan berhenti sebentar sebelum lanjut ke makanan utama.
- Porsi makan utama dibuat sedang, bukan porsi besar sekaligus.
- Pilih lauk yang direbus, dikukus, dipanggang, pepes, atau ditumis ringan.

> **Contoh lokal yang cenderung lebih aman:** nasi hangat dengan telur rebus, pepes tahu, sayur bening, sup ayam bening, atau oatmeal kecil setelah buka ringan.

Yang sering bikin kambuh cepat

- Langsung makan besar saat adzan, terutama jika penuh gorengan atau santan kental.
- Sambal banyak, kuah sangat pedas, soda, kopi pekat, atau teh sangat kental pada awal berbuka.
- Makanan sangat asam jika Anda memang sensitif, misalnya cuka kuat, jeruk sangat asam, atau tomat dalam jumlah besar.
- Minum banyak sekaligus sampai perut terasa penuh sekali.

Langkah praktis: bila perut sedang sangat sensitif, mulai dari setengah porsi dulu, berhenti sejenak, baru lihat apakah lambung terasa lebih tenang.

4) Makan malam dan snack ringan: fokus pada porsi sedang, bukan sering lapar lalu kalap

Setelah makan utama, sebagian pasien masih lapar lagi pada malam hari. Itu boleh diatur, tetapi pilih snack yang ringan dan jangan menjadikan jam malam sebagai sesi makan berat kedua.

Porsi sedang lebih aman
Bagi banyak pasien, makan sedang lebih nyaman daripada satu kali makan sangat banyak.

Catat pola pemicu pribadi
Kalau kopi, cokelat, sambal, atau gorengan konsisten bikin kambuh 2-3 kali, anggap itu pemicu pribadi Anda.

Snack ringan bila perlu
Pisang matang, roti tawar, biskuit plain, oatmeal kecil, atau sup hangat sering lebih bersahabat untuk lambung sensitif.

Jangan makan terlalu larut
Makan makin mepet tidur biasanya makin memudahkan refluks pada pasien yang sensitif.

Hindari makan berat kedua
Mi pedas, gorengan banyak, atau makan larut malam sering menjadi pemicu lebih

besar daripada jenis lauk itu sendiri.

Tidur lebih nyaman

Bila keluhan sering muncul malam, usahakan kepala lebih tinggi dan jangan pakai pakaian terlalu ketat setelah makan.

5) Sahur dan cairan: jangan mepet, jangan sekaligus banjir minum

Kemenkes menekankan kebutuhan cairan tetap harus dipenuhi selama puasa, umumnya sekitar 8 gelas per hari yang dibagi dari berbuka sampai sahur. Untuk lambung sensitif, pembagiannya lebih nyaman bila dicicil, bukan ditumpuk sekaligus menjelang imsak.

Yang disarankan saat sahur

- Usahakan sahur tidak terlalu mepet, jadi masih ada waktu duduk tegak setelah makan.
- Pilih menu yang hangat, tidak terlalu pedas, tidak terlalu berminyak, dan ada sumber protein seperti telur, ikan, tempe, atau tahu.
- Air putih dicicil: sebagian saat bangun, sebagian saat makan, lalu sebagian lagi setelah selesai makan.
- Kalau mudah kembung, porsi sahur jangan dipaksakan terlalu besar.

Contoh sederhana: nasi dengan telur rebus dan sayur bening, atau roti dengan telur dan buah yang tidak terlalu asam.

Yang sering memicu saat sahur

- Kopi pekat saat perut masih kosong atau saat lambung sedang aktif kambuh.
- Makan sangat pedas dan sangat berminyak lalu langsung tiduran lagi.
- Minum banyak sekaligus karena takut haus, lalu perut terasa penuh dan begah.
- Sahur terlalu mepet sampai tidak ada jeda untuk tubuh tetap tegak.

Catatan konservatif: tidak semua orang harus berhenti kopi selamanya, tetapi saat keluhan sedang aktif kopi pekat sering jadi pemicu yang layak dikurangi dulu.

6) Pemicu yang sering bikin kambuh saat puasa

NIDDK menyebut beberapa makanan dan minuman yang umum memicu refluks: kopi atau kafein, makanan tinggi lemak, makanan pedas, cokelat, dan makanan asam pada sebagian orang. Di kehidupan sehari-hari, pola makan juga sama pentingnya dengan jenis makanannya.

Makanan dan minuman yang sering perlu dibatasi

- Gorengan, makanan tinggi lemak, santan kental, dan porsi besar sekaligus.
- Sambal banyak, seblak sangat pedas, kuah yang terlalu merangsang.
- Kopi, teh kental, soda, cokelat, dan minuman energi.
- Buah atau minuman yang sangat asam pada pasien yang memang sensitif.

Kebiasaan yang sama seringnya jadi pemicu

- Makan sangat cepat lalu langsung rebahan.
- Sahur mepet imsak lalu tidur lagi tanpa jeda.
- Merokok dan stres yang tidak terkelola.
- Sering minum obat anti-nyeri seperti ibuprofen, aspirin dosis nyeri, atau asam mefenamat tanpa arahan.

Langkah praktis: pilih 2-3 pemicu yang paling terasa dulu untuk dikurangi. Pasien biasanya lebih berhasil kalau perubahan dibuat spesifik, bukan semua hal diubah sekaligus.

7) Obat dan kebiasaan yang perlu hati-hati

Bagian ini sengaja dibuat konservatif. Tujuannya membantu pasien aman, bukan memberi jadwal obat yang bisa keliru. Kalau Anda sudah punya obat lambung dari dokter, aturan minumnya tetap mengikuti resep yang diberikan untuk kondisi Anda sendiri.

Kalau sudah punya obat resep

- Minum sesuai instruksi dokter atau farmasis. Waktu minum tiap obat bisa berbeda.
- Jangan menaikkan dosis sendiri hanya karena takut kambuh saat puasa.
- Kalau jadwal obat membingungkan saat Ramadan, konsultasikan ulang sebelum meneruskan.

Catatan: halaman ini tidak menggantikan aturan obat individual.

Obat dan kebiasaan yang bisa memperberat

- NSAID tanpa pengawasan, rokok, dan alkohol.
- Sering mengandalkan obat bebas tanpa mengecek penyebab kalau keluhan berulang terus.
- Menahan gejala berat berhari-hari karena merasa "nanti juga reda".

Naikkan evaluasi: kalau obat bebas makin sering dibutuhkan, keluhan muncul hampir setiap puasa, atau gejala mulai beda dari pola biasa.

8) Siapa yang sebaiknya konsultasi dulu sebelum lanjut puasa

Tidak semua pasien dengan keluhan lambung punya risiko yang sama. Ada kelompok yang sebaiknya diskusi dulu dengan dokter agar keputusan puasanya lebih aman dan jadwal obatnya tidak asal.

Riwayat lambung berat

Pernah perdarahan lambung, tukak, muntah darah, BAB hitam, atau sering kambuh berat saat Ramadan sebelumnya.

Penyakit kronis atau obat khusus

Penyakit ginjal, hati, jantung, diabetes, penggunaan pengencer darah, steroid, atau NSAID rutin.

Kondisi khusus lain

Kehamilan, usia lanjut, berat badan turun tanpa sebab, anemia, sulit menelan, atau alergi obat berat.

Tujuan konsultasi: memastikan gejala memang stabil, jadwal obat aman, dan ada rencana jelas bila keluhan muncul saat sedang puasa.

9) Kapan harus ke dokter, dan kapan harus langsung ke IGD

Bagian ini wajib dibaca sampai selesai. Banyak pasien menunda terlalu lama karena mengira semua keluhan lambung bisa ditahan sampai buka berikutnya. Padahal sebagian gejala perlu evaluasi cepat.

Periksa ke dokter dalam waktu dekat bila:

- Keluhan tidak membaik walau pola buka, makan, dan sahur sudah dirapikan.
- Gejala sering kambuh malam, sering perlu obat bebas, atau sampai mengganggu tidur.
- Sering mual, cepat kenyang, berat badan turun, atau nafsu makan turun.
- Anda merasa perlu menghindari semakin banyak makanan karena hampir semua terasa memicu.
- Ada riwayat tukak, sering minum NSAID, atau gejala berulang hampir setiap Ramadan.

Makna evaluasi: dokter menilai apakah ini keluhan lambung biasa, refluks yang lebih aktif, efek obat, tukak, atau masalah lain yang meniru maag.

Segera ke IGD bila ada tanda bahaya:

- Nyeri dada berat atau menekan, terutama kalau menjalar ke rahang, lengan, punggung, atau disertai sesak.
- Muntah darah, muntah seperti kopi, atau BAB hitam seperti aspal.
- Muntah terus sampai tidak bisa masuk minum, tampak sangat lemas, atau tanda dehidrasi.
- Sulit menelan, nyeri menelan makin berat, atau makanan seperti tersangkut.
- Pusing berat, keringat dingin, hampir pingsan, atau pingsan.

Jangan tunggu besok: red flag ini bisa menandakan perdarahan, dehidrasi berat, sumbatan, atau masalah jantung yang kebetulan terasa seperti maag.

10) FAQ singkat yang sering ditanyakan pasien

Kalau keluhannya ringan, boleh tetap puasa?

Apakah semua pasien harus berhenti kopi saat sahur?

Kalau minum obat lambung, boleh atur jadwal sendiri saat Ramadan?

Kapan puasa sebaiknya dihentikan hari itu?

11) Rujukan edukasi resmi

Konten diperbarui pada **10 Maret 2026**. Copy pasien disederhanakan dari sumber resmi berikut:

1. Kemenkes RI, *Puasa Lancar, Badan Tetap Sehat dan Bugar*, 18 Maret 2025: https://ayosehat.kemkes.go.id/puasa-lancar-badan-tetap-sehat-dan-bugar

2. Kemenkes RI, *Cegah Dehidrasi Saat Puasa dengan 8 Gelas Perhari*, 4 April 2023: https://ayosehat.kemkes.go.id/cegah-dehidrasi-saat-puasa-dengan-8-gelas-perhari
3. NIDDK, *Symptoms & Causes of GER & GERD*, last reviewed July 2020: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/symptoms-causes
4. NIDDK, *Eating, Diet, & Nutrition for GER & GERD*, last reviewed July 2020: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/eating-diet-nutrition
5. NICE guideline CG184, *Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia in adults*, last reviewed 18 October 2019: https://www.nice.org.uk/guidance/cg184
6. NHS, *Indigestion*, page last reviewed 5 May 2023: https://www.nhs.uk/conditions/indigestion/

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Kontak Cepat

WhatsApp

Google Maps

Instagram

Jam Layanan

Senin - Minggu: 24 Jam

Telepon: +62 822-1718-0432

© 2026 Zihan Medical Center